Université Abderrahmane Mira-Béjaïa
Faculté de Médecine
Département de Médecine
Enseignement de la 3ème année médecine
Unité d'Enseignement Intégrée 2
Modules de la Sémiologie

Sémiologie Neurologique

troubles de la sensibilité:
la tétanie, les syndromes médullaires, bulbaires, thalamiques

Dr CHIBANI K

LA TÉTANIE

- C’est un syndrome sensitivo-moteur évoluant par crises paroxystiques
- **L'accès tétanique :**

- Comporte des troubles sensitifs et des troubles moteurs dont la répartition topographique est particulière; ils affectent les extrémités : mains, pieds, et la région péribuccale

✓Les troubles sensitifs : sont constants

➢Les troubles subjectifs : à type de paresthésies : fourmillements et picotements, puis impression d'enraidissement.

➢Les troubles objectifs : hypoesthésie tactile et profonde

✓Les troubles moteurs : sont des contractions soutenues, involontaires et incoercibles d'intensité modérée, non douloureuses.

LA CRISE DE TÉTANIE

- La crise commence par des troubles sensitifs débutant par les doigts et les orteils sans jamais dépasser le coude, ni le genou, puis apparaissent les troubles moteurs
- se caractérisent par des contractures fortes et prolongées des muscles des mains, qui se présentent avec les doigts en forme de cône, ou de fuseau (mains d'accoucheur).
- Plus rarement, les contractures touchent les pieds, et quelquefois le visage

- La durée de la crise va de quelques minutes à quelques heures

CONTRACTURES

- S'accompagnent généralement de **crampes** et de **paresthésies** (sensations de fourmillements).
- Le plus souvent, ces contractures s'accompagnent d'angoisse, de malaises, et d'une respiration accélérée.

CONTRACTURES

- **La main d'accoucheur :**
  - Le pouce en extension et adduction
  - Les doigts serrés les uns contre les autres à demi fléchis
  - La paume est creusée par le rapprochement de ses deux bords
  - Le poignet peut être en demi-flexion



CONTRACTURES

Aux membres inférieurs

- Les orteils se mettent en flexion plantaire serrés les uns contre les autres,
- la plante est creusée comme la paume de la main
- Les pieds sont cambrés

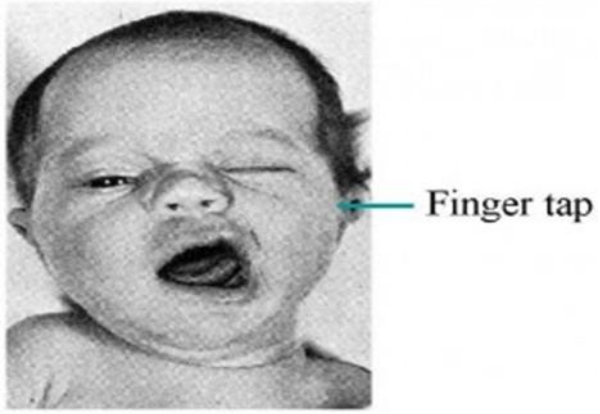




CONTRACTURES

Chez le jeune enfant

- l'attitude du poing est la plus fréquente, la contracture péri buccale peut réaliser des attitudes de moue ou « de museau de carpe » et il existe des risques de laryngospasme entraînant une apnée.



ENTRE LES CRISES DE TÉTANIE

- Des troubles sensitifs objectifs à type d'hypoesthésie tactile des doigts peuvent persister
- **Le signe de Chvostek:** c'est la contraction de l'orbiculaire des lèvres lors de la percussion de la joue au milieu d'une ligne unissant le lobule de l'oreille et la commissure labiale (percussion d'un nerf : branche temporo-faciale du nerf facial)
- **Le signe de Weiss:** c'est la contraction de l'orbiculaire des paupières lors de la percussion de l'angle externe de l'œil
- **Le signe de Lust:** c'est la contraction des muscles de la loge antéro-externe de la jambe lors de la percussion du sciatique poplité externe au col du péroné.
- Tous ces signes peuvent être négatifs, on essaiera alors de déclencher un accès tétanique par **l'épreuve du garrot** qui consiste à poser sur le bras pendant 10 minutes un garrot ischémiant, puis à l'enlever, chez le tétanique cette manœuvre déclenche un accès c est le signe de Trousseau.

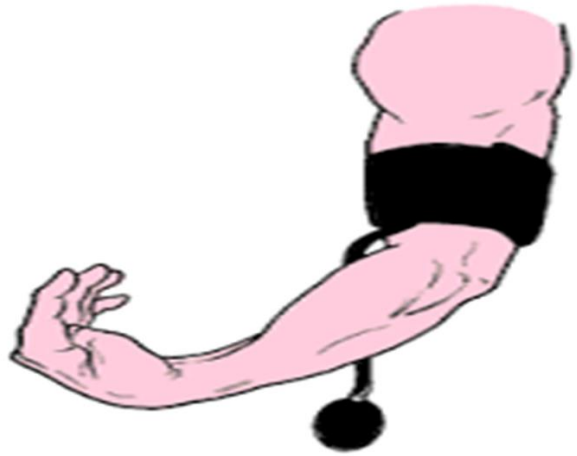
SIGNE DE CHVOSTEK





SIGNE DE TROUSSEAU

- Pose autour du bras d'un garrot ou d'un brassard (d'un appareil de tension artérielle par exemple)
- la pression provoque une contracture de l'avant-bras, et de la main



Diagnostics différentiels

- La spasmophilie.
- Des **crampes musculaires**

Étiologies

- **Hypocalcémie**
- **Hypovitaminose D**
- **Pancréatite aiguë**
- Transfusions massives de **sang citraté**
- **Hyperaldostéronisme**
- **Hypomagnésémie**
- Hypokaliémie
- Alcalose
- **Lait** riche en phosphate, parfois à l'origine de tétanie chez l'enfant

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

- le dosage de la **calcémie: hypo**
- Le dosage de la **phosphorémie**: hyper
- **Le dosage de la magnésémie** : hypo

LES SYNDROMES SENSITIFS D'ORIGINE CENTRALE

Ils peuvent avoir pour origine:

1. Une atteinte de la moelle
2. Une atteinte du bulbe
3. Une atteinte du thalamus
4. Une atteinte du cortex

1-AU NIVEAU DE LA MOELLE

- Il traduit une lésion focale médullaire qui retentit sur :
  - Le nerf périphérique qui sort de la moelle au niveau de la lésion: syndrome lésionnel
  - Les voies montantes et descendantes (sensitives, pyramidales et végétatives): sd sous lésionnel
  - Troubles sphinctériens

LE SYNDROME MÉDULLAIRE COMPLET

- Se voit dans les paraplégies qui réalisent une lésion complète de la moelle, soit par section médullaire (post-traumatique), soit par compression

- On observe alors une anesthésie ou hypoesthésie à tous les modes dans le territoire situé au-dessous de la lésion

- La limite supérieure du trouble de la sensibilité à une valeur capitale pour le diagnostic topographique de la lésion médullaire surtout en cas de compression médullaire.

LES SYNDROMES MÉDULLAIRES PARTIELS: LÉSION DE L'HÉMI-MOELLE DROITE OU GAUCHE

- Réalise **le syndrome de Brown-Sequard** associant :

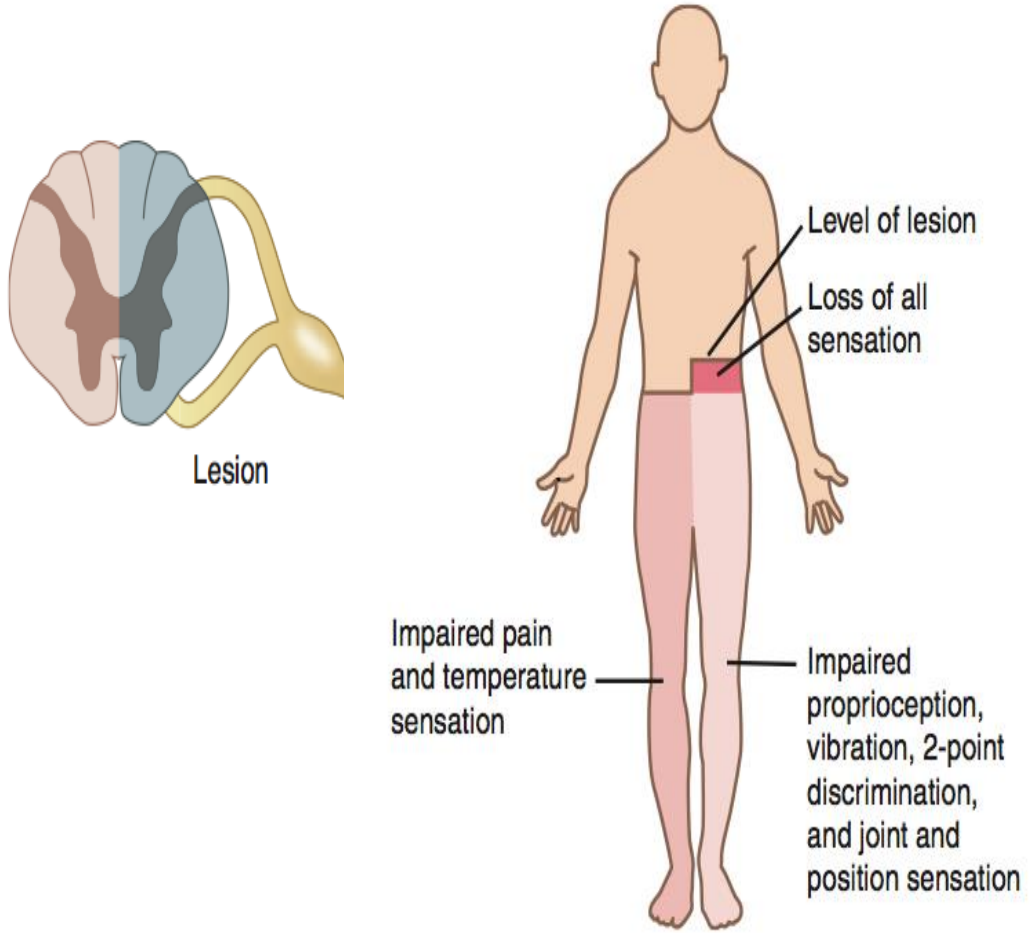
Sd lésionnel: sd neurogène périphérique du niveau de l'atteinte

Sd sous lésionnel: (atteinte pyramidale et proprioceptive homolatérale; spino-thalamique controlatéral)

- Du côté de la lésion : des troubles de la sensibilité profonde et des troubles moteurs à type de paralysie

- Du côté opposé à la lésion des troubles de la sensibilité thermo-algésique

BROWN SEQUARD SYNDROME



LES SYNDROMES MÉDULLAIRES PARTIELS
UNE LÉSION CENTRO-MÉDULLAIRE

- située autour du canal épendymaire, va entraîner des troubles isolés de la sensibilité thermo-algésique « en bande » ou « suspendue » avec conservation de la sensibilité profonde

- c'est la classique dissociation syringomyélique

- La lésion centro-médullaire intéresse en hauteur seulement quelques segments médullaires au niveau du renflement cervical d'où l'aspect suspendu des lésions et en largeur la lésion va non seulement intéresser les fibres spino-thalamiques, mais aussi la corne antérieure, d'où l'association caractéristique
  - anesthésie thermo-algésique en bande avec conservation de la sensibilité profonde
  - paralysie avec amyotrophie siégeant au niveau de la ceinture scapulaire, des bras et des mains
  - troubles trophiques des membres supérieurs

LES SYNDROMES MÉDULLAIRES PARTIELS: UNE LÉSION DES CORDONS POSTÉRIEURS

le syndrome cordonal postérieur

- Peut s'accompagner de troubles sensitifs subjectifs dont le plus caractéristique est la douleur fulgurante ou douleur en éclair
- Les troubles sensitifs objectifs vont porter uniquement sur la sensibilité profonde; ils associent :
  - Une ataxie
  - Une abolition de la sensibilité vibratoire au diapason
  - Une perte du sens de position segmentaire des membres
  - Une astéréognosie : perte de la reconnaissance palpatoire des objets
  - Il n'y aura pas de troubles de la sensibilité thermo-algésique d'où le nom de dissociation tabétique : car ce tableau a d'abord été décrit dans le tabès (syphilis nerveuse), il peut se voir également au cours de l'avitaminose B 12, tm compressive, SEP.

LES SYNDROMES MÉDULLAIRES PARTIELS: UNE LÉSION DES CORDONS POSTÉRIEURS

le syndrome cordonal postérieur

- L’ataxie : l'ensemble des troubles moteurs apparaissant lors de la fermeture des yeux

  ✓Troubles du maintien des attitudes : avec **signe de Romberg et signe de la main instable ataxique** : on demande au sujet de maintenir ses mains tendues en avant, doigts écartés; lors de la fermeture des yeux, la main et les doigts présentent des oscillations

  ✓Troubles des mouvements : avec troubles de la marche : démarche talonnante et anomalies du mouvement finalisé : le mouvement est mal dirigé, hésitant et le but est manqué : dysmétrie

LES SYNDROMES MÉDULLAIRES PARTIELS: UNE LÉSION DES CORDONS POSTÉRIEURS 2

- Une abolition de la sensibilité vibratoire au diapason
- Une perte du sens de position segmentaire des membres
- Une astéréognosie : perte de la reconnaissance palpatoire des objets
- Il n'y aura pas de troubles de la sensibilité thermo-algésique d'où le nom de dissociation tabétique : car ce tableau a d'abord été décrit dans le tabès (syphilis nerveuse), il peut se voir également au cours de l'avitaminose B 12.

2-AU NIVEAU DU BULBE

LE SYNDROME DE WALLENBERG

- C’est l’ atteinte de la région latérale du bulbe
- C’est un syndrome alterne sensitif (dû à un ramollissement du bulbe par ischémie artérielle dans le territoire vertébro-basilaire)
- **Du côté de la lésion:** on observe
  - Une hypoesthésie ou une anesthésie thermo-algésique dans le territoire du trijumeau
  - Avec conservation de la sensibilité tactile (en effet parmi les noyaux sensitifs du V seul le noyau spinal est touché, car il s'étend sur toute la hauteur du bulbe et il est le relais des afférences thermiques et douloureuses; les autres noyaux du V en particulier, le noyau principal qui est le noyau de la sensibilité tactile siège au niveau de la protubérance)
  - paralysie de l'hémi-voile, de l'hémi-pharynx et de la corde vocale
  - Un syndrome de Claude Bernard Horner
  - Un syndrome vestibulaire
  - Un hémisyndrome cérébelleux

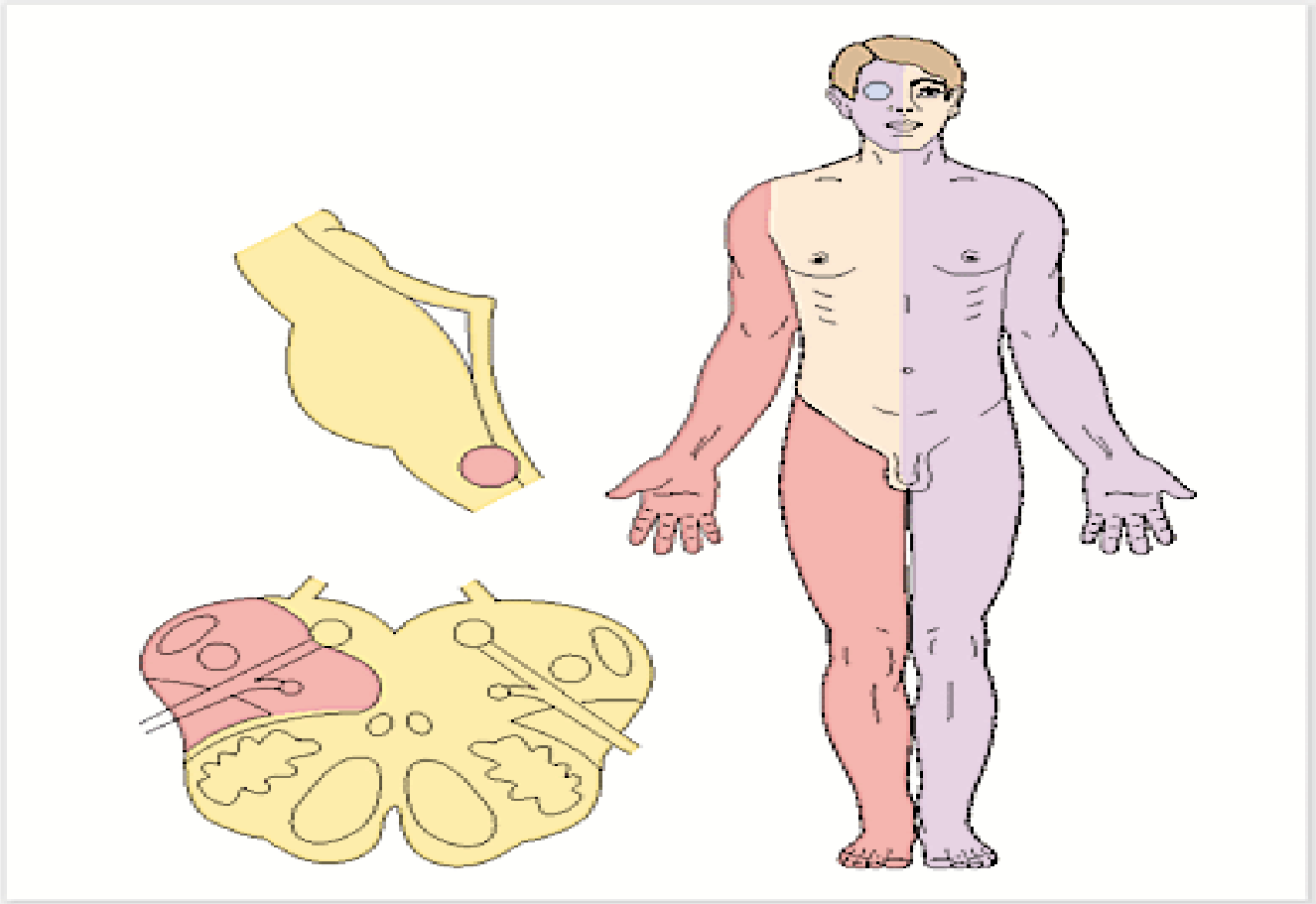
LE SYNDROME DE WALLENBERG 2

- **Du côté opposé à la lésion :**

  - Une hémi-anesthésie thermo-algésique des membres supérieurs et inférieurs réalisant avec l'anesthésie faciale du côté de la lésion, le syndrome sensitif alterne

  - Une hémiparésie peut être observée.

SYNDROME DE WALLEMBERG



http://www.elsevier-data.de/rochelexikon5a/pics

3-AU NIVEAU DU THALAMUS

LE SYNDROME CAPSULO-THALAMIQUE DE DEJERINE-ROUSSY

- La lésion intéresse le noyau postéro-ventral du thalamus et déborde sur la capsule interne et les radiations optiques
- Il va se manifester du côté opposé à la lésion
- Des troubles sensitifs subjectifs à type d'hyperpathie.
- Des troubles de la sensibilité profonde et des troubles de la sensibilité thermo-algésique
- Une hémianopsie latérale homonyme
- Une hémiparésie.

4-AU NIVEAU DU CORTEX

AU NIVEAU DU CORTEX

- Les lésions du cortex pariétal vont entraîner des troubles sensitifs de la moitié opposée du corps souvent limités à une partie du corps du fait de l'étalé ment de la représentation somatotopique sensitive

- Ces troubles sensitifs portent essentiellement sur la sensibilité profonde : trouble du sens des positions sédentaires et astéréognosie

- Les troubles de la sensibilité superficielle sont seulement à type d'hypoesthésie.

RÉFÉRENCES

- Précis de sémiologie
- Dr. Pierre Potier. Collège National Des Enseignants De La Médecine Interne. Neurologie.
- Collège des enseignants de neurologie. Sémiologie Analytique. Syndromes sensitifs.
- Baptiste coustet. Sémiologie médicale: l'apprentissage pratique de l'examen clinique. 2008 éditions Estem